

Fecha Última Actualización: 26-09-2022 17:06:30

Página 1 de 4

Información Paciente

Nombre : Jacinto Adrian Sepulveda Arancibia **Rut** : 4.431.244-1 **N° Archivo** : 0208228 **N° Epicrisis**
Edad : 78a 9m 11d **Fecha Nacto**: 15/12/1943 **Sexo** : Masculino **308137**
Dirección : Juan De Dios Malebran 2521, Villa La Fore **Comuna** : Puente Alto **Teléfono** : 9 8128 7852

Información Hospitalización

Unidad de Ingreso : Emergencia Adulto **Fecha Ingreso** : 14/05/2022 20:10 **Días Estadía**: 135
Unidad de Egreso : Medicina Agudos (4tp Piso) **Fecha Egreso** : 26/09/2022 16:06

Motivo o Diagnóstico de Ingreso

Insuficiencia Respiratoria Aguda

Comorbilidades

Procedimientos

Intervenciones Quirúrgicas

Epidemiología

Resumen Clínico

FECHA DE INGRESO HSR/Geriatria: 14/05/22
FECHA DE INGRESO UPC: 22/05/22
FECHA DE INGRESO UTIM: 17/08/22

ANTECEDENTES:

·Mórbidos: FA paroxística en TACO con intentos de CVE a principios de año, HTA, ICC con FeVI de 47%, CC con MIBI-DIPI sugerente de infarto anteroapical e inferoseptal basal con leve isquemia residual, ENS
·Quirúrgicos: RTU + cistolitotomía, hernia inguinal bilateral
·Fármacos: Losartan 50 mg c/12 horas, Xarelto 15 mg/día, Metformina 850 mg/día, AAS 100 mg/día, Amiodarona 200 mg/día, Atorvastatina 40 mg/día, Amlodipino 5 mg/día
·Alergias: (-)
·Hábitos: TBQ (+) 7 cig/día, OH (+) 3 Lt de vino a la semana, DRG (-)
·Hospitalizaciones: (-)

ANAMNESIS

Paciente con antecedentes descritos, con historia de FA con controles en extrasistema. Relata historia de deterioro en capacidad funcional de un año de evolución. Refiere una semana de empeoramiento de disnea basal, llegando incluso al reposo, asociado a tos seca y sensación de obstrucción bronquial. No refiere aumento de edemas periféricos, sin fiebre, sin odinofagia, sin congestión nasal, sin dolor tipo puntada con tope inspiratorio.

Ingresa a SU en BCG, con requerimientos de O2 de 2 Lt por NRC, se toma RxTx con infiltrados bilaterales. Se sospecha NAC, se inicia terapia empírica con Unasyn y se traslada a UGA. Evoluciona con bradicardia asintomática, evaluado por cardiología, en plan de MCPD. Se toma TAC de Tórax, compatible con infiltrados bilaterales tipo vidrio esmerilado, sugerentes de patología inflamatoria infecciosa vs congestión, además de enfisema de predominio lóbulos superiores. Evoluciona con requerimientos de O2 y PI al alza, se escala terapia a Unasyn/Azitromicina, y finalmente a Imipenem/Vancomicina por mala evolución, se agregan corticoides sistémicos, BD, corticoides inhalados y terapia depletiva. Por requerimientos de O2 al alza requiere paso a CNAF y eventualmente conexión a VMNI, con PaFI de 85. En ese contexto se decide IOT, conexión a VMI y traslado a UPC

DIAGNÓSTICOS DE INGRESO A UPC

1.SDRA severo multifactorial
a.NAC severa

Fecha Epicrisis : 26/09/2022 17:06

Página 1 de 4

- b. ICC descompensada
- c. Obs LCFA exacerbada
- 2. AKI sobre ERC
- 3. FA lenta asintomática
- 4. Antecedentes

EVOLUCIÓN POR PLANES EN UPC

1. Hemodinamia: Inicialmente con DVA a dosis bajas en contexto de sedoanalgesia. Se Tx 1 UGR por Hb 8.8, no queda claro motivo. Recibe terapia depleitiva de manera intermitente dado congestión y falla renal. Posteriormente evoluciona hipertenso, inicia VDO. 27/07 en contexto de hit infeccioso cursa nuevamente con requerimientos de VDA, suspendidas precozmente.
2. CV: Con antecedente de ENS, cursando bradicardia asintomática a su ingreso a UPC. El 28/05 en contexto de toma de TAC cursa con bradicardia hasta 30, se administró adrenalina, posteriormente cursa con FV hasta 220 en unidad de rayos, se describe episodio autolimitado, con FC peri 50 lpm a su regreso a UPC. No se desfibrila, se objetivaron signos de bajo gasto por lo que se instaló SMPC transitoria, con posterior pacing de 100%. Evoluciona con ritmo propio, se retira SMPC el 11/06. Por RVR se inicia Digoxina, manteniéndose posteriormente en RS, RVA.
3. Respiratorio: Cursando SDRA severo, por PaFI 100 se decide inicio de BNM y ciclo de PP 24/05-27/05, logrando descenso de FiO2 hasta 40% y mejoría de PaFI hasta 178. Se toma AngioTAC de Tórax, negativo para TEP, con progresión de infiltrados y patrón sugerente de organización. En ese contexto, y dado estudio MB (-), se deciden bolos de MPDN el 31/05 250 mg x 5 días, con posterior tapering de prednisona. Lenta mejoría tras pulsos, requiere reinicio de BNM transitoriamente, posteriormente dado evolución favorable logra ventanas de CPAP. Se realiza TQT percutánea el 15/06, posteriormente SMIV y CPAP intermitente, requiriendo paso P/AC de manera intermitente por delirium. Logra salidas a filtro el 12/07, suspendiendo corticoides. Tras 72 horas cursa con deterioro ventilatorio dado hit infeccioso, requiriendo nuevamente P/AC. Se sospecha exacerbación, recibe nuevamente pulsos de MPDN por 5 días, actualmente con prednisona en decalaje. Logra nuevamente mejoría ventilatoria, logrando pasar 48 horas en filtro por lo que se decide traslado a UTIM.
4. Infeccioso: A su ingreso a UPC con cobertura empírica con Imipenem/Vancomicina, PV (-), PCR COVID (-) x 2, sin posibilidad de CAET. Se realiza LBA el 24/05, mostrando abundantes secreciones adherentes, por lo que se deja en sistema de nebulización continúa. Estudio MB (-), se suspende Vancomicina tras 3 días e Imipenem tras 7 días. Desde entonces varios hits:
- a. 05/06 febril, se reinicia Imipenem, con HC 1 y 2 (+) para Enterobacter cloacae MS, se asocia Amikacina. Además con crecimiento de S. Capitis en HC a las 13 horas, se agrega Vancomicina. Completa 10 días de ambos.
 - b. 28/06 NAVM por A. Baumannii/E. Cloacae, se trata con Gentamicina NBZ + Cotrimoxazol en dosis de profilaxis, completa 14 días
 - c. 14/07 NAVM + shock séptico por ACBA MS, tratado con Unasyn, por mala respuesta y deterioro se escala a Colistin EV + Gentamicina NBZ, posteriormente se agrega Vancomicina. Se pancultiva 27/07, con HC 1/2 (+) S. Capitis a las 22 horas, se suspende Vancomicina dado que se considera contaminación. Completa 14 días de colistín
2. Renal/MI: Cursó con AKI e hipernatremia moderada que fue manejada con agua bidestilada EV, logrando recuperación de Crea y Na. Posteriormente nueva AKI en contexto de uso de Colistin/Vancomicina, con Crea hasta 2.2, ya en descenso, actualmente 1.3.
3. Neuro: Posterior a suspensión de sedoanalgesia cursa con delirium hiperactivo que requiere BIC de Precedex, ya suspendida.

DIAGNÓSTICOS DE INGRESO A UTIM

- 1. SDRA severo
 - a. NAC grave Obs COP
 - b. VMI prolongada con TQT 15/06
 - 2. AKI KDIGO II
 - a. Obs NTA Colistin/Vancomicina
 - 3. FA paroxística lenta
 - a. Obs ENS
 - 4. Crítico crónico
 - a. Trastorno de la deglución severo
 - b. Miopatía
 - c. Polineuropatía
 - 5. Antecedentes
 - Resueltos
- NAVM por ACBA/E. Cloacae

Fecha Última Actualización: 26-09-2022 17:06:30

Página 3 de 4

Bacteriemia por E. Cloacae/S. capitis
Shock séptico de foco respiratorio por ACBA

EVOLUCIÓN POR PLANES EN UTIM

1. Hemodinamia: Inicialmente estable, sin necesidad de DVA. En contexto de nuevo hit infeccioso/respiratorio desde 17/09 cursa con deterioro progresivo que, dada AET, se decide no iniciar terapia con vasoactivos.

1.1 Cardiovascular: ENS con tendencia a la bradicardia. El 28/05 presenta bradicardia hasta 30, administrándose adrenalina; evoluciona con FV -autolimitada- por lo que se realiza desfibrilación. Se objetivan signos de bajo gasto por lo que se instaló SMPT el 11/06, evolucionando posteriormente con ritmo propio y sin req. de dispositivo. El 21/08 presenta FA con RVR sin compromiso hemodinámico, sin dolor torácico ni compromiso de conciencia, manejándose de manera farmacológica con respuesta adecuada.

2. Respiratorio: Insuficiencia Respiratoria Aguda por neumonía organizante. Recibió pulsos de MTP en dos ocasiones. El 06/09 se realizó cambio de TQT a una número 8.5. Logró 96 horas sin conexión a VMI, pero el 17/09 presenta nuevo deterioro ventilatorio que se sospecha tras aspirar contenido alimenticio por TQT. Debido a que persiste con fugas, se cambió a TQT n° 9, sin incidentes, pero paciente persiste con franco deterioro en lo pulmonar, sin posibilidad de desconexión de BiPAP. Control de scanner con fibrosis y progresión de compromiso parenquimatoso. Según lo discutido con equipo y familia y no respuesta a manejo ATB adecuado se decide limitación de esfuerzo terapéutico enfocado en confort.

3. Infectológico:

Intercurrencias resueltas:

- Bacteriemia por E. cloacae y S. capitis tratado con vancomicina y amikacina.
- NAVM por ACBA y E. cloacae tratada con gentamicina nebulizada.
- NAVM y shock séptico por ACBA tratado con colistín y nebulizaciones con gentamicina.
- NAVM sin microbiología, se trató con ampicilina/sulbactam/meropenem.
- Traqueobronquitis (NAVM por SAMS y ACBA -- con BIC Cloxacilina + AMS, completó 14 días).
- SDA por CD recibiendo Vancomicina por SNG, con regular respuesta

Dado deterioro reciente y alza de PCR, se decide prolongar duración con ATB ajustado. Evoluciona con parámetros inflamatorios al alza, probablemente en contexto de foco respiratorio (el 15/09 se aspiró contenido alimentario desde TQT). El 17/09 se inició Imipenem + Vancomicina empírico, sin conseguir mejoría clínica o de parámetros de laboratorio.

Se discute en equipo y con familia y se decide suspensión de ATB (se mantiene vancomicina para efecto esencialmente sinomático) y se prioriza confort

4. Nefrológico: Múltiples episodios de AKI, última 2ria a Colistín y Vancomicina, resuelta.

5. Rehabilitación: En lo FNA se mantiene en régimen cero, iniciando VF terapéutica con mala tolerancia. Se descarta posibilidad de GTT. Discutido con equipo, se iniciará manejo proporcional.

6. Profilaxis: Anticoagulado por FA - suspendida por expectoración sanguinolenta y anemia progresiva.

El 26/09 a las 16:06 se constata fallecimiento de paciente, que se encontraba acompañado por familiar.

Se realiza certificado de defunción con diagnósticos

- Shock séptico de foco pulmonar

- Neumonía organizante

Concomitantes: Síndrome diarreico agudo por C difficile, fibrilación auricular, insuficiencia cardíaca

Se entrega certificado y carnet de identidad a esposa para efectuar trámites.

Diagnóstico de Egreso

Sdra Severo. Pafio2 87 -
Tep Masivo? -
Nac Ats Iv -
Icc Aguda Descompensada -
Fa Bloqueada (Rv Lenta Con Conduccion Aberrante) -
Aki Sobre Erc -
Antecedentes -
Insuficiencia cardiaca izquierda descompensada -

Condición de Egreso Fallecido

Egreso con Catéter Doble J:NO

Fecha Epicrisis : 26/09/2022 17:06

Página 3 de 4

Fecha de Impresión : Martes, 05 de Mayo de 2026 15:32

Usuario Impresión : Andres Aquevedo Salazar

Fecha Última Actualización: 26-09-2022 17:06:30

Página 4 de 4

Paciente fallecido el 26/09 a las 16:06.

Plan Post Alta

Paciente fallecido

Indicaciones

Tipo de Reposo :

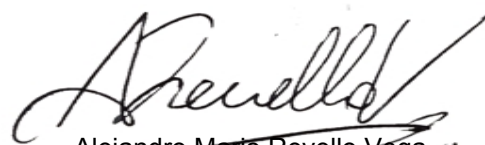
Régimen Alimentario :

Medicamentos :

Controles

INTERNO

Becado/Residente



Alejandro Mario Revello Vega

Médico Tratante (Staff)